リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月14日（土）

第63号　朝刊

きょうの紙面　▸回復期リハ × 退院後　▸心臓リハ × 評価　▸パーキンソン病 × 嚥下　▸短信 8本

■ 回復期リハ × 退院後

退院後もリハ医が診ると6か月後のADLが高く

回復期リハ病棟協会32施設・183人　退院時は同じBI、6か月後に差

回復期リハビリテーション病棟協会の32施設で、2021年8月に回復期リハ病棟を退院した65歳以上の183人を後ろ向きに調べた研究が、Frontiers in Rehabilitation Sciencesに載った。退院後もリハ医の定期診察を受けた89人と、受けなかった94人を、バーセル指数（BI）で比べている。

退院時のBIはどちらも中央値90で差がなかったが、1か月後は85対75、6か月後は90対75と開いた。年齢や病気、退院時のBI、退院後のリハの利用などをそろえた重回帰でも、定期診察はBIが約12点高いこと（95%信頼区間5.2〜19.6）と結びついていた。外来・訪問・通所のリハを使った人も79.8%対22.3%と多かった。

ただし観察研究で、施設ごとの差も統計で扱っておらず、診察を受けた人ほど退院後のリハにつながっており。医師の診察そのものの効果とは分けられず、著者らも前向きの研究と費用の検討が要るとしている。退院後に誰が経過を見続け、地域のリハへつなぐのかを、病棟の退院支援の段階から決めておく意味を示す結果だ。



退院の日で、回復は終わらない。

出典 Frontiers in Rehabilitation Sciences ↗

数字で見る

183人
退院した65歳以上

90対75
6か月後のBI中央値

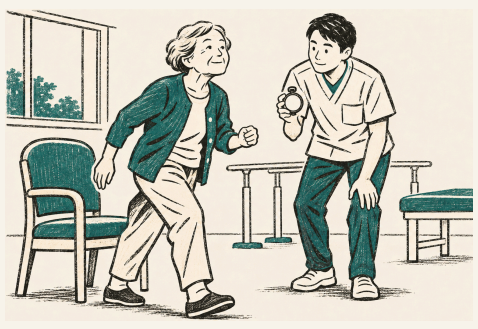
12点
調整後のBIの差

■ 心臓リハ × 評価

循環器PTの必須評価 回復期後半は205項目

日本循環器理学療法学会の標準化委員会に所属する加藤倫卓氏らが、外来・在宅の運動療法を続ける時期の評価を修正デルファイ法でまとめた。理学療法士63人が3回答え、70%以上が必須とした320項目中205項目を採った。急性期版で外れた体重変化率、TUG、身体活動量と座位時間、HDS-R、MNA、SARC-Fが加わった。

学会の公式な指針ではなく、身体活動量やMNAは71.4%と基準を1人分超えての採用だった。回答者の専門の偏りも限界に挙がる。退院後の心リハで何を測り続けるかを見直す土台になる。



出典 循環器理学療法学 ↗

■ パーキンソン病 × 嚥下

嚥下の評価は 薬の効く時間で変わる

パーキンソン病の82人で、ベッドサイドの嚥下スクリーニング（GUSS）と嚥下造影を、ドパミン系の薬が効いている時間内か時間外かで比べた。薬が効いている時間内はGUSSが16.9点対14.6点と高く、誤嚥の深さを示すPASは中央値2.0対3.5と低かった。

時間外に造影した人ほど液体のとろみ調整を勧められていた。1施設の観察研究で因果は言えないが、評価の時刻と服薬の時刻を記録に残すと、食形態の判断の読み方が変わる。



出典 Neurological Sciences ↗

短信

〈退院支援〉米国で退院前訪問は少数
米国の入院リハ61施設の調査。退院前の家屋訪問は44%が行うが、対象は患者の1%ほど。 出典 Br J Occup Ther ↗

〈脳卒中〉小脳刺激で二重課題が改善
亜急性期脳卒中26人のRCT。小脳刺激を足すと、計算しながら立つ時の揺れが減った。 出典 PubMed ↗

〈車椅子〉当事者が講師の研修で技能向上
当事者が共同講師の2日間研修で、OT・PT17人の技能が38%上がった。対照群なし。 出典 PubMed ↗

〈嚥下〉舌の超音波は補助の指標
神経筋疾患の6研究のSR。舌の超音波は補助になるが、誤嚥の予測は舌の筋力が上。 出典 PubMed ↗

〈医療AI〉誤るAIを医師は見抜けず
医師48人のRCT。心音判定AIの誤りが増えると、自分で先に判定しても精度が落ちた。 出典 npj Digit Med ↗

〈骨折〉認知の急な低下で骨折1.86倍
3か国14,282人。認知機能が急に下がる人は大腿骨近位部骨折が1.86倍。観察研究。 出典 Osteoporos Int ↗

〈制度〉リハ議連がPTOT法改正に意欲
議員連盟の会長が、約60年実質改正のないPTOT法の改正を推すと表明。3団体も要望。 出典 POST ↗

〈小児〉小児リハの開始は4割台
米国の小児リハ紹介8,533件で、実際に始まったのは42.7%。通いやすさや費用が壁。
出典 Arch Phys Med Rehabil ↗